

Malang, 7 Juli 2026

No. Surat : 57/WVI/CGPP/JT/VII/2026
Lampiran : 1
Hal : Undangan Peserta

Yth.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
di Tempat

Dengan hormat,

CORE Group Partners Project (CGPP) melalui Wahana Visi Indonesia (WVI) mendukung upaya eradikasi polio melalui penguatan program imunisasi dan surveilans di Kabupaten Malang. Dalam rangka mendukung upaya tersebut, kami bermaksud menyelenggarakan kegiatan **"Refreshment Training Mengenai Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dan New All Record (NAR) dalam Mendukung Penguatan Surveilans PD3I di Kabupaten Malang"**. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petugas kesehatan dalam melaksanakan kewaspadaan dini dan respon terhadap kasus PD3I menggunakan aplikasi SKDR dan NAR di Kabupaten Malang.

Sehubungan dengan hal tersebut, Tim CGPP Indonesia – Jawa Timur dengan hormat mengundang kesediaan **Bapak/ Ibu Penanggung jawab Surveilans dari Puskesmas dan Rumah Sakit yang berada di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Malang**. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 22 Juli 2026
Pukul : 08.30 – 15.30 WIB
Lokasi : Ruang Rapat Gerha Bakti Praja (Ghabaja) BKPSDM Kabupaten Malang
Jl. KH. Agus Salim No.7 Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang
Peserta : (daftar peserta terlampir)

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, mohon dapat menghubungi Dwi Putri Juliana Purba (0812-6811-5101). Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami




Intan Permata Hati Gea, S.KM., M.Epid
Provincial Team Leader East Java – CGPP Indonesia

Lampiran 1.
Daftar Peserta Undangan

No	Nama Instansi	Keterangan Unsur peserta
1	Dinas kesehatan Kabupaten Malang	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang
2		Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)
3		Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi
4		Ahli Madya Pengampu Surveilans
5		Ahli Madya Pengampu Imunisasi
6		Penanggung Jawab Surveilans
7		Penanggung Jawab Imunisasi
8		Pengadministrasi Perkantoran
9	RSUD Lawang	Penanggung Jawab Surveilans
10	RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang	
11	RS Prima Husada	
12	RS Sumber Sentosa	
13	RS Umum Wawa Husada	
14	RS Marsudi Waluyo	
15	RS Umum Universitas Muhammadiyah Malang	
16	RS Lawang Medika	
17	RS Siti Miriam Lawang	
18	RS Umum Pindad	
19	RS Prasetya Husada	
20	RS Mitra Delima	
21	RS Bala Keselamatan Bokor	
22	RSU Wajak Husada	
23	RSI Gondang Legi	
24	RS Radjiman Wediodiningrat	
25	Puskesmas Donomulyo	Penanggung Jawab Surveilans
26	Puskesmas Kalipare	
27	Puskesmas Pagak	
28	Puskesmas Sumbermanjing Kulon	
29	Puskesmas Bantur	
30	Puskesmas Wonokerto	
31	Puskesmas Gedangan	
32	Puskesmas Sitiarjo	
33	Puskesmas Sumbermanjing Wetan	
34	Puskesmas Dampit	
35	Puskesmas Pamotan	
36	Puskesmas Tirtoyudo	
37	Puskesmas Ampelgading	

38	Puskesmas Poncokusumo
39	Puskesmas Wajak
40	Puskesmas Turen
41	Puskesmas Bululawang
42	Puskesmas Gondanglegi
43	Puskesmas Ketawang
44	Puskesmas Pagelaran
45	Puskesmas Kepanjen
46	Puskesmas Sumberpucung
47	Puskesmas Kromengan
48	Puskesmas Ngajum
49	Puskesmas Wonosari
50	Puskesmas Wagir
51	Puskesmas Pakisaji
52	Puskesmas Tajinan
53	Puskesmas Tumpang
54	Puskesmas Pakis
55	Puskesmas Jabung
56	Puskesmas Lawang
57	Puskesmas Singosari
58	Puskesmas Ardimulyo
59	Puskesmas Karangploso
60	Puskesmas Dau
61	Puskesmas Pujon
62	Puskesmas Ngantang
63	Puskesmas Kasembon

Kerangka Acuan Kerja
Refreshment Training Mengenai Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)
dan New All Record (NAR) dalam Mendukung Penguatan Surveilans
PD3I di Kabupaten Malang
Rabu, 22 Juli 2026

No. TOR: 025/APSimokerto/CGPP/VII/FY26

1. Latar Belakang

Indonesia sebelumnya menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB) polio akibat *circulating Vaccine Derived Poliovirus type 2* (cVDPV2) yang terjadi pada periode November 2022 hingga Juli 2024 di beberapa provinsi. Meskipun KLB polio telah dinyatakan berakhir pada tahun 2025, upaya mempertahankan status bebas polio dan mencegah munculnya kembali kasus polio maupun Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) lainnya tetap memerlukan kewaspadaan. Salah satu upaya penting dalam mendukung eradikasi polio dan pengendalian PD3I adalah terselenggaranya sistem surveilans yang mampu mendeteksi kasus secara dini sehingga investigasi dan respon dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Dalam mendukung pelaksanaan surveilans tersebut, Kementerian Kesehatan telah mengembangkan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi KLB penyakit menular serta *New All Record* (NAR) sebagai platform pencatatan dan pelaporan surveilans yang mendukung pengelolaan data secara terintegrasi. Keberhasilan pelaksanaan surveilans memerlukan keterlibatan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit, dalam melakukan penemuan, pelaporan, investigasi, dan respon terhadap kasus PD3I.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Malang periode Januari–Mei 2026, masih ditemukan kasus dan suspek PD3I seperti campak, difteri, pertusis, dan *Acute Flaccid Paralysis* (AFP). Pada surveilans AFP, baru 1 dari 39 puskesmas yang mencapai target penemuan minimal satu suspek AFP, sedangkan 38 puskesmas lainnya belum mencapai target. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sensitivitas surveilans masih perlu diperkuat. Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang juga menekankan pentingnya penguatan penemuan dan pelaporan kasus di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit, serta pelaporan kasus dalam waktu kurang dari 24 jam agar investigasi dan respon dapat segera dilakukan.

Hasil *baseline survey* pada 39 puskesmas di Kabupaten Malang menunjukkan masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan surveilans PD3I. Sebanyak 21% puskesmas pernah mengalami KLB, sementara pelaksanaan pelaporan dan investigasi kasus masih menghadapi kendala berupa data yang belum lengkap, keterlambatan pelaporan, keterbatasan informasi, pergantian petugas, serta keterlambatan pemeriksaan laboratorium. Selain itu, 54% petugas surveilans belum pernah mengikuti pelatihan surveilans dalam enam bulan terakhir, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas deteksi dini, pelaporan, investigasi, dan pemanfaatan data surveilans.

Sejalan dengan hasil tersebut, peningkatan kapasitas petugas melalui *refreshment* menjadi salah satu strategi untuk memperkuat kualitas surveilans PD3I. *Refreshment* ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan petugas dalam pemanfaatan SKDR dan NAR, pelaporan dan verifikasi kasus, investigasi epidemiologi, analisis data, serta koordinasi antara puskesmas,

rumah sakit, dan Dinas Kesehatan dalam mendukung deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi KLB.

Sejalan dengan upaya penguatan sistem imunisasi dan surveilans, Pemerintah Amerika Serikat melalui *United States Department of State (U.S. DoS)* bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam mendukung penguatan program imunisasi dan surveilans melalui *Core Group Partners Project (CGPP)* yang diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia (WVI). Oleh karena itu, diperlukan kegiatan *Refreshment Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)* dan *New All Record (NAR)* bagi petugas surveilans 39 puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten Malang guna meningkatkan kapasitas petugas dalam pelaksanaan surveilans PD3I serta mendukung deteksi dini, pelaporan, investigasi, dan respon kasus secara cepat, tepat, dan berkualitas.

2. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan *refreshment training* ini adalah:

- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petugas mengenai kebijakan, surveilans, penyelidikan epidemiologi, pengaplikasian dan pemanfaatan SKDR dan NAR sesuai pedoman yang berlaku.
- Meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan deteksi dini, pelaporan kasus, verifikasi *alert*, investigasi epidemiologi, dan respon terhadap potensi KLB secara cepat dan tepat.
- Meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan analisis, interpretasi, dan pemanfaatan data surveilans.
- Memperkuat koordinasi antara puskesmas, rumah sakit, dan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan surveilans PD3I.

3. Output Kegiatan

Adapun output dari kegiatan *refreshment training* ini adalah :

- Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman petugas mengenai kebijakan, surveilans, penyelidikan epidemiologi, pengaplikasian dan pemanfaatan SKDR dan NAR sesuai pedoman yang berlaku.
- Meningkatnya kemampuan petugas dalam melakukan deteksi dini, pelaporan kasus, verifikasi *alert*, investigasi epidemiologi, dan respon terhadap potensi KLB
- Meningkatnya kemampuan petugas dalam melakukan analisis, interpretasi, dan pemanfaatan data surveilans.
- Meningkatnya koordinasi antara puskesmas, rumah sakit, dan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan surveilans PD3I.

4. Lokasi dan Agenda Kegiatan

Nama : Refreshment Training Mengenai Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)
Kegiatan dan New All Record (NAR) dalam Mendukung Penguatan Surveilans PD3I
di Kabupaten Malang
Waktu : Rabu, 22 Juli 2026
Tempat : Ruang Rapat Gerha Bakti Praja (Ghabaja) BKPSDM Kabupaten Malang
Jl. KH. Agus Salim No.7 Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang
Agenda :

Selasa, 21 Juli 2026

Waktu	Durasi	Kegiatan	PJ/Narasumber	Ket
09.00 – 11.00	120'	Meeting coordination dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang	Tim CGPP	

Rabu, 22 Juli 2026

Waktu	Durasi	Kegiatan	PJ/Narasumber	Ket
08.30 – 09.00	30'	Registrasi Peserta	Panitia	
09.00 – 09.10	10'	Pembukaan Acara dan Doa	MC	
09.10 – 09.20	10'	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	MC	
09.20 – 09.30	10'	Kata Sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang	Dinas Kesehatan Kabupaten Malang	
09.30 – 09.45	15'	Pre Test	Panitia	
09.45 – 10.15	30'	Materi 1: Kebijakan Surveilans Kewaspadaan Dini (SKDR dan NAR)	Kementerian Kesehatan	
10.15 – 11.00	45'	Materi 2: Sistem Pelaporan SKDR IBS (Indikator Base Surveilans)	Kementerian Kesehatan	
11.00 – 11.20	20'	Tanya Jawab		
11.20 – 12.20	60'	Ishoma		
12.20 – 12.25	5'	Ice Breaking		
12.25 – 13.10	45'	Materi 3: Sistem Pelaporan EBS (Event Based Surveillance)	Kementerian Kesehatan	
13.10 – 13.30	20'	Tanya Jawab		
13.30 – 14.30	60'	Materi 4 Penyelidikan Epidemiologi, Implementasi SKDR dan NAR (Termasuk Praktik Penyusunan Buletin)	Dinas Kesehatan Provinsi	
14.30 – 14.50	20'	Diskusi		
14.50 – 15.05	15'	Post Test	Panitia	
15.05 – 15.25	20'	Rencana tindak Lanjut	CGPP-WVI & Dinas Kesehatan Kabupaten Malang	
15.25 – 15.30	5'	Penutup	MC	

SURABAYA

Jalan Margorejo Indah XI No.335 Blok C, Margorejo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60238 |
+62 811-9318-564



wahanavisi_id

www.wahanavisi.org



Wahana Visi Indonesia

5. Peserta

Peserta dalam kegiatan ini mengundang Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Penanggungjawab Surveilans Puskesmas Kabupaten Malang, Penanggungjawab Surveilans Rumah Sakit Kabupaten Malang, dan Tim CGPP – Wahana Visi Indonesia. Rincian peserta adalah sebagai berikut :

Instansi	Jabatan	Jumlah
Kementerian Kesehatan	Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan	1 orang
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P)	1 orang
Dinas Kesehatan Kabupaten Malang	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang	1 orang
	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (P2P)	1 orang
	Ahli Madya Pengampu Surveilans	1 orang
	Ahli Madya Pengampu Imunisasi	1 orang
	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	1 orang
	Penanggungjawab Surveilans	1 orang
	Penanggungjawab Imunisasi	1 orang
	Pengadministrasi Perkantoran Surveilans Imunisasi	1 orang
Puskesmas di Kabupaten Malang	Penanggungjawab Surveilans	39 orang
16 Rumah Sakit di Kabupaten Malang	Penanggungjawab Surveilans	16 orang
Tim CGPP – WVI	Tim Kerja Kabupaten Malang	5 orang
	Staf Kebersihan Gedung	10 orang
Total		80 orang

6. Pendanaan **Kegiatan**
 Pendanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran Tim CGPP-WVI tahun 2026, meliputi transportasi dari tempat tinggal peserta ke tempat kegiatan dan konsumsi.

7. Penutup
 Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Diharapkan kegiatan *refreshment training* ini dapat meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam penggunaan SKDR dan NAR, memperkuat kualitas pelaporan dan surveilans, serta mendukung deteksi dini, respon cepat terhadap potensi kejadian penyakit, dan peningkatan kualitas program kesehatan di Kabupaten Malang.